

合乳房按摩，以排出瘀积的乳汁，使乳络畅通，肿块消散，则疾病速愈。与其它治疗方法相

比，此法操作简单有效，无任何副作用，不受设备和技术限制，经济实用，病人容易接受，值得

推广应用。

(收稿日期：2001年3月1日)

民间验方治疗泄泻举隅

王志梅¹ 陈林兴²

(1 昆明水泥厂职工医院，云南 昆明 650109；2 云南中医学院，云南 昆明 650200)

摘要 举例说明一些民间验方在泄泻治疗中的运用体会，阐述民间验方的科学性、实用性，认为民间验方的临床运用也要遵循中医理论及辨证论治原则，才能取得理想的疗效。

关键词 民间验方 泄泻 运用体会

泄泻是临床常见的病证。以排便次数增多，粪便稀薄，甚至泻出如水样为特点。多由正气内虚，感受外邪，饮食不节或七情不和损伤脾胃所致。笔者认为该病的病变关键在于邪阻肠道中焦气机升降失常，因此临床上针对病因病机尝试着用一些民间验方进行治疗，收到了较好的疗效，现举验案数则，谈谈自己的一点粗浅的体会，谨供同道参考。

1 以通为用，巧用大黄

病案1：伍某，女，56岁，本厂退休工人，2001年5月20日初诊。

主诉：腹泻反复发作3年，加重2周。

患者素有“结肠炎”病史，曾于3年前行“结肠息肉摘除术”，随后经常服用“黄连素”、“丽珠肠乐”等西药，但疗效不稳定，腹泻时轻时重，反复发作。近2周来，腹泻日3~4次，大便夹不消化物，时夹粘液，有里急后重感，腹隐痛，胃脘饱闷食后愈甚，口干苦。查舌尖红边有齿痕，苔秽腻，脉细数。

辨证：肝脾失调，湿热积滞。治以疏肝理气，清热消积。方选柴平汤加大黄粉治之，具体

方药如下：

炒柴胡 12g，黄芩 10g，潞党参 12g，半夏曲 15g，枳实 10g，厚朴 10g，苍术 12g，陈皮 10g，神曲 15g，焦山楂 15g，香附 10g，炙甘草 6g，（另包）酒炒大黄 3g，2剂。

以上方药水煎服，大黄研末，以药汤送服，每服1g，日3服。

5月23日复诊：药后大便较畅，每次量较多，解出许多不消化物及风沫粘液，次数减为每日2次，腹痛口苦均减。效不更方，原方续进3剂。

5月26日复诊：大便稍偏稀，日2行，无粘液风沫，觉口淡乏味，胃时饱闷，嗳气。查舌淡有齿印，苔白腻，脉缓。

此属肠道湿热已去，虚象显露，以参苓白术散调理善后，服药10余剂而愈。

按：《素问·灵兰秘典论》说：“小肠者，受盛之官，化物出焉。”“大肠者，传导之官，变化出焉。”一旦肠腑发生病变，必然“变化”无权、“化物”少能而在肠道形成积滞，久泻者中州渐亏，难以运化，积滞愈甚，肠道分清泌浊功能紊乱，更致腹

泻缠绵难愈，可见积滞既是肠道病变的产物又是导致泄泻的病因，因此临证遵循“必伏其所主而先其所因”的原则，每从“陈莖去而肠胃洁”之说立法，先行通腑，取源远流长，积去泻止之意。大黄一药素有“将军”之称，通腑泻热、破积消滞之力甚强，民间常用之治疗热积腹痛、赤白痢疾、便秘等，此病案中运用，用酒炒大黄，去其苦寒之性，配以柴平汤吞服，寓消于收，泻中有补，通因通用，使积滞去而泄泻止，疗效满意。

2 洁净腑，以实大便

病案2：翟某，男，7岁，学生，2000年7月5日就诊。

患者腹痛腹泻2天，大便稀粥样，色黄腥臭，腹痛即泄，日4~5行，肛门灼热，口干喜冷饮，小便短赤，舌尖红苔黄，脉数。

证属：暑湿互结，治以清热利湿。

内服方：绿豆 15g，六一散 15g（成药），扁豆 10g，车前草 15g，水煎服，日服3次，日1剂。

外用方：茯苓、苍术、车前子、滑石、泽泻、黄连各等份，

冰片适量，共研末，凡士林调匀敷脐，每日1换。

患儿用上方2剂后泄泻止，小便恢复正常。

按：泄泻一病，与湿邪关系最大，所谓“湿胜则濡泄”、“无湿不成泻”，7月乃夏令暑湿季节，暑湿伤及脾胃，传化失常，小肠的清泌浊异常则大便稀薄，小便短少，暑湿阻于肠腑则见肛门灼热，大便腥臭。治湿之法，古有“开鬼门”、“洁净府”两大法，临床体会：治暑湿泄泻首推利小便，因淡渗利湿之品，不腻不燥，其药性又顺从湿邪下趋走向，能因势利导，使肠道之湿下渗膀胱，排出体外而大便自实。方中绿豆清热解暑、扁豆健脾利湿，六一散、车前草清热利尿，配合外用清热利湿方，共奏清热解暑，利湿止泻之功。

3 疏运气机，升清降浊

病案3：王某，女，32岁，昆明发电厂职工，2001年9月27日就诊。

患者腹泻2年，常因忧思恼怒，情绪波动致腹泻发作或加重，腹胀痛，肠鸣矢气多，腹痛欲泻，泻后则舒，西医诊断为“慢性肠炎”，多方治疗未愈。平素患者多愁善感，月经失调，经前胸胁胀痛伴腹泻，经后诸症消失，舌尖红，苔薄腻，脉弦滑。

证属肝泻夹瘀热，为肝气犯脾之病，予疏肝理气，健脾助运，予痛泻要方2剂，方药如下：

陈皮10g，苍术12g，防风10g，杭芍15g，酒大黄炭2g^(后下)，枳实10g，元胡10g。

2剂后诸症大减，嘱其以下方经常服用，巩固疗效。

佛手片、老柚子皮、红茶、红糖各适量，泡水服，3月后来告知，泄泻已愈，月经恢复正常。

按：《医碥·泄泻》述：“有肝气滞两胁而泻者，名肝泄。”肝主疏泄，具生发条达之性，可助中焦之运化，也能调脏腑之传导，若脾气素虚，肝失条达，横逆乘脾，则气机失调，清气不升，浊气不降，则腹痛泄泻。此例病案正如张景岳所言：“凡遇怒气便作泄者，必先怒时挟食数伤脾胃，故但有所犯，即随触而发，此肝脾二脏之病也，盖以肝木克土，脾气受伤而然。”针对病机，以痛泻要方调理肝脾气机，加大黄炭、枳实消积导滞，取得较好疗效后，以佛手、柚子皮疏肝理气，红茶、红糖健脾涩肠，巩固疗效。

4 消补合用，温涩合参

病案4：李某，男，50岁，教师，1999年10月24日初诊。

患者腹泻3月，清晨6时左右即腹痛肠鸣需入厕，解稀溏便夹少许粘液，无里急后重感，泻后则安。近2周来大便次数增加每日3~5次，纳减，怕冷，腰酸腹胀，眠差，查舌淡胖夹青边有齿痕，脉沉细。

证属脾肾阳虚，运化失常。治宜温补肾阳，佐以健脾消食。因患者怕服汤药，故以散剂辅以外治法。

内服：焦楂炭、山药、补骨脂、五倍子^(醋炒)各等份研末，每服6g，米汤加放红糖适量送服，日服2次，10天为1疗程。

外敷方：吴茱萸、五味子、石榴皮各等份，研末醋调敷脐，1日1换，10天为1疗程。

患者按上方用药1疗程后，泄泻止，诸症减轻，嘱停外治法，内服药继续服用，每次量减为3g，连服1月，诸症悉愈。

按：此例患者属久泻伤及脾肾之阳，法当温阳涩肠止泻，然考虑到久泻多兼食积、瘀滞，因此用药不可一味温补，以山药健脾助运，补骨脂温肾助阳，五倍子涩肠止泻，焦楂炭消食导滞，米汤温润脾肺二脏，外治以吴茱萸温运脾阳、疏泄肝气，五味子温肾纳气，石榴皮行气涩肠止泻，诸药消补同用，温涩合参，收效甚好。

5 体会

民间验方是广大劳动人民在长期的生活和劳动实践中积累的医疗经验，在民间广为流传，有价廉方简、取材容易、实用性强等特点，但也存在着口头相传，药物名称不规范，不辨寒热而泛用的问题，使其推广运用，提高疗效受到了一些限制。泄泻一病，临床常反复发作，缠绵难愈，久泄者疗程亦较长，有些患者难以坚持服汤药，因此笔者撷取了一些民间验方，根据临床实际，辨证加减以用之，采用多途径给药结合食疗诸法，疗效满意。由此可见，遵循中医理论及辨证论治原则，灵活运用单方、民间验方治病有助于提高验方疗效，进一步证明其科学性、实用性，利于推广运用。

参考文献

- 1 张伯臾. 中医内科学. 上海: 上海科学技术出版社, 1983, 151~155
- 2 湖南中医药研究所. 简易中医疗法. 北京: 人民卫生出版社, 1986, 27~32
(收稿日期: 2002年1月6日)

民间验方治疗泄泻举隅

作者: [王志梅](#), [陈林兴](#)
作者单位: [王志梅\(昆明水泥厂职工医院, 云南, 昆明, 650109\)](#), [陈林兴\(云南中医学院, 云南, 昆明, 650200\)](#)
刊名: [中国民族民间医药杂志](#)
英文刊名: [CHINESE JOURNAL OF ETHNOMEDICINE AND ETHNOPHARMACY](#)
年, 卷(期): 2002 (3)

参考文献(2条)

1. [张伯臾](#) [中医内科学](#) 1983
2. [湖南中医药研究所](#) [简易中医疗法](#) 1986

引用本文格式: [王志梅](#), [陈林兴](#) [民间验方治疗泄泻举隅](#)[期刊论文]-[中国民族民间医药杂志](#) 2002 (3)